

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί *η ταχεία πρωτογενής εκτίμηση* για καταστάσεις επικίνδυνες για τη ζωή, ακολουθεί ένας πιο λεπτομερής, ανά συστήματα, κλινικός έλεγχος. Αυτός ο έλεγχος, λόγω των αφόρητων πιέσεων – πανταχόθεν – για γρήγορη διακομιδή, συχνά παραλείπεται, με ολέθρια συνήθως αποτελέσματα για τον τραυματία ασθενή μας!

Η δεύτερη αξιολόγηση (*δευτεροβάθμιος έλεγχος*) επιτελείται αφού έχει ολοκληρωθεί η εκτίμηση των ζωτικών λειτουργιών (Α, Β, C, D, E) και έχουν αντιμετωπιστεί επιτυχώς οι άμεσα απειλητικές για τη ζωή κακώσεις ή καταστάσεις. Περιλαμβάνει τη σαφή, λεπτομερή καταγραφή και περιγραφή των στοιχείων, την αξιολόγηση και βαθμολόγηση της βαρύτητας των κακώσεων. Η δεύτερη εξέταση του ασθενούς είναι πιο λεπτομερής και συστηματική και κατά κανόνα αρχίζει από την κορυφή (κεφαλή), προχωρεί προς τον κορμό και τα κάτω άκρα και πρέπει να ολοκληρώνεται ταχύτατα (συνήθως μέσα σε χρόνο 10 λεπτών).

- ✓ Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο να μη ελέγχεται ο ασθενής στην οπίσθια επιφάνεια του σώματος και εκ των υστέρων να ανακαλύπτονται τεράστια αιματώματα στην γλουτιαία χώρα, στην οσφύ ή στο τριχωτό της κεφαλής, τα οποία να αποτελούν τη βασική αιτία της υποογκαιμίας. Δεν πρέπει επίσης να παραλείπεται η επισκόπηση και ψηλάφηση της οπίσθιας επιφάνειας του κορμού (*μέθοδος log-roll*), όπως αναφέρθηκε στο “βήμα E - Exposure” της πρωτοβάθμιας εκτίμησης, με την προϋπόθεση ότι κύριο μέλημα, πάντοτε, είναι η διατήρηση της σταθερότητας της ΣΣ, ιδίως αν υποπτευόμαστε τραυματισμό της.

Προσεκτική επισκόπηση και ψηλάφηση της ράχης και της οσφύς, του κρανίου και των οστών του προσώπου, για έλεγχο καταγμάτων και διαταραχών της αισθητικότητας. Έλεγχος για **σημείο Battle’s** (οπισθοωτιαίο αιμάτωμα). Εξέταση των οφθαλμών για τον έλεγχο της οπτικής οξύτητας, ανισοκορίας, διαταραχές οφθαλμοκινητικότητας, έλεγχο για την παρουσία ή όχι του **σημείου Raccoon Eyes**, αποκάλυψη ξένων σωμάτων, κ.ά.

- ✓ Πολλές φορές παραλείπεται η **τοποθέτηση σκληρού κηδεμόνα (κολάρου) της ΑΜΣΣ** και αν αυτό συμβεί ξεχνάμε να ακινητοποιήσουμε και τις άλλες μοίρες της σπονδυλικής στήλης (ΣΣ). Η ΣΣ ακινητοποιείται μετά από κάθε τροχαίο ατύχημα ή πτώση από ύψος, θεωρώντας ότι έχει υποστεί κάκωση μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου. Ο αποκλεισμός ασταθούς κακώσεως της ΣΣ πρέπει να γίνεται μόνο από τον ειδικό ιατρό. Ο μηχανισμός κάκωσης, όπως και οι συνοδές κακώσεις, αποτελούν ισχυρά προνοσοκομειακά κριτήρια για την επαρκή ακινητοποίηση της ΣΣ και την ασφαλή μεταφορά του ασθενούς.

Η πρόσθια επιφάνεια του τραχήλου, πρέπει επίσης, να εξετάζεται για οίδημα και να ψηλαφείται για ανίχνευση κριγμού ή ευαισθησίας, καθώς και να ελέγχεται για πιθανή διάταση των σφαγιτίδων (*καρδιακός επιπωματισμός ή υπό τάση πνευμοθώρακας*).

Η οπίσθια επιφάνεια του τραχήλου ψηλαφείται για έλεγχο δυσμορφίας των ακανθωδών επιφύσεων της ΑΜΣΣ και για ύπαρξη ευαισθησίας. Διατιτραίνοντα τραύματα πρέπει να ελέγχονται για πιθανή συμμετοχή στη διάτρηση του μυώδους πλατύσματος.

- ✓ Στο στάδιο αυτό απαιτείται η πλήρης **φυσική εξέταση του θώρακα**. Επισκόπηση αρχικά του θωρακικού τοιχώματος για χαλαρό θώρακα (ή *παράδοξη αναπνοή*), ακρόαση για απουσία ή ασυμμετρία του αναπνευστικού ψιθυρίσματος, επίκρουση για την αναζήτηση αμβλύτητας ή τυμπανικότητας και ψηλάφηση για διαπίστωση υποδορίου εμφυσήματος, κριγμού ή οστικής ευαισθησίας στο στήρνο ή τις πλευρές ή όποιων άλλων ευρημάτων.

- ✓ **Κοιλιά και πύελος:** Επισκόπηση για αιματώματα, εκχυμώσεις, διάταση, ευαισθησία και σημεία περιτοναϊκού ερεθισμού του κοιλιακού τοιχώματος. Εκχυμώσεις στο περίνεο, στο όσχεο ή στα χείλη του αιδοίου υποδηλώνουν κάταγμα πυέλου (**σημείο Cooper nail**). Εκτιμάται αδρά η σταθερότητα της πυέλου με την άσκηση ήπιας πίεσης στα λαγόνια και την ηβική σύμφυση (ειδικά σε πολυτραυματίες, ηλικιωμένους, τραύματα καταπλάκωσης). Διατιτραίνοντα τραύματα του θώρακα σε επίπεδο κάτωθεν των θηλών ή στη ράχη κάτω από τη γωνία της ωμοπλάτης, πρέπει να θεωρούνται ως ύποπτες κακώσεις της κοιλιάς και να αντιμετωπίζονται ως τέτοιες μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο.

- ✓ **Η τοποθέτηση ρινογαστρικού καθετήρα (Levin)**, για την αποσυμπίεση του στομάχου, επειδή σε νευρογενές shock προκαλείται γαστροπάρεση και για παρακολούθηση τυχόν αιμορραγίας από το ανώτερο πεπτικό, κρίνεται απολύτως αναγκαία. Εκτός αυτού, στα παιδιά και τους ηλικιωμένους, η γαστρική διάταση είναι πολύ πιθανό να συμβάλλει σε αιμοδυναμική επιδείνωση. Η γαστρική αποσυμφόρηση κρίνεται επίσης απαραίτητη για τους διασωληνωμένους ασθενείς, ενώ, τέλος, η πορεία του ρινο- ή στοματο-γαστρικού σωλήνα μπορεί να υποδείξει αορτικό ή διαφραγματικό τραυματισμό.
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται επί υποψίας κατάγματος της βάσεως του κρανίου (που πολλές φορές παραβλέπεται), οπότε και τοποθετείται ο σωλήνας Levin στοματογαστρικά.
- ✓ **Η δακτυλική εξέταση** για τον έλεγχο της θέσης του προστάτη, του τόνου του σφιγκτήρα (υπόνοια τραυματισμού της ΣΣ σε ελαττωμένο τόνο) και της παρουσίας αίματος, καθώς επίσης και ο διουρηθρικός καθετήρας (Foley) στην κύστη δεν πρέπει να παραλείπονται. Αιμορραγία από ρήξη του εντέρου ή της ουροδόχου κύστεως είναι συχνά ευρήματα.
- ✓ **Η τοποθέτηση ουροκαθετήρα Foley** επιτρέπει την παρακολούθηση της αποβαλλόμενης ποσότητας ούρων, άρα την εύκολη αιμοδυναμική παρακολούθηση του ασθενούς, εκτός εάν υπάρχει υποψία κατάγματος (αστάθειας) της πυέλου, ρήξης ουρήθρας ή κύστεως. Η ολιγουρία είναι ένα από τα πλέον πρώιμα κι αξιόπιστα συμπτώματα της υποογκαιμίας. Τα εξωτερικά γεννητικά όργανα πρέπει να επισκοπούνται για ανίχνευση αιματώματος ή εκχύμωσης, ενώ σε περίπτωση κοιλικής αιμορραγίας (λόγω κατάγματος της πυέλου) είναι απαραίτητη η αμφίχειρη γυναικολογική εξέταση, πάντοτε με ήπιους χειρισμούς. Ο πριαπισμός, επίσης, αποτελεί κακό προγνωστικό σημείο στον πολυτραυματία.
- ✓ **Άκρα:** Κάθε άκρο πρέπει να ελέγχεται για τραύματα, δυσμορφίες, οίδημα, ευαισθησία, κριγμό, περιορισμένη κινητικότητα και παθολογικές σφύξεις. Πριν και μετά από κάθε χειρισμό σε ένα τραυματισμένο άκρο πρέπει να εκτιμάται η νευροαγγειακή κατάσταση (για αποφυγή του συνδρόμου διαμερίσματος και κατ' επέκταση ισχαιμίας του άκρου). Επιβάλλεται η προσωρινή ακινητοποίηση των μη επιπεπλεγμένων καταγμάτων.
- ✓ **ΗΚΓφική παρακολούθηση:** Συνεχής έλεγχος του καρδιακού ρυθμού είναι απαραίτητος, τόσο κατά την παραμονή στο ΤΕΠ, όσο και κατά τη διάρκεια της διακομιδής, για την έγκαιρη ανίχνευση και θεραπεία επικίνδυνων διαταραχών της καρδιακής λειτουργίας ή θανατηφόρων αρρυθμιών, λόγω υποογκαιμίας ή κακώσεων της ίδιας της καρδιάς.
- ✓ Χορήγηση **αντιτετανικού** ορού (HTIG: inj. Tetagam-P, 250 IU) και άμεσα χορήγηση **αντιβίωσης** ευρέως φάσματος για κάλυψη για κοινά αερόβια και αναερόβια μικρόβια.
- ✓ Επανεξιλημμένος κλινικός έλεγχος και παρακολούθηση των ζωτικών σημείων (ΑΠ, ΗΚΓ, SpO₂, RR) κατά τη διακομιδή και την τελική αντιμετώπιση σε κέντρο τραύματος. Βασικό μέλημά μας η χορήγηση, πρώιμα, **επαρκούς αναλγησίας** στον πολυτραυματία ασθενή.
- ✓ Η λήψη καλού ιστορικού είναι ζωτικής και πρωταρχικής σημασίας στην περίπτωση του πολυτραυματία. Οι διάφορες πληροφορίες που ενδιαφέρουν πρωταρχικώς τους θεράποντες ιατρούς μπορούν να ληφθούν από ποικίλες πηγές (συγγενείς, περίοικους, από το πλήρωμα του ασθενοφόρου ή ακόμα και από τον ίδιο τον ασθενή όταν αυτό είναι δυνατό).
Με τη συστηματική καταγραφή στοιχείων του ιστορικού του ασθενούς, όπως αυτή μπορεί να επιτευχθεί με το απλό πρότυπο του ιστορικού **A-M-P-L-E** (Allergies, Medication, Previous illnesses - Pregnancy, Last meal, Environment - Events associated with injury), αποφεύγεται οποιαδήποτε δυνητικά επικίνδυνη παράλειψη σημαντικών κλινικών πληροφοριών.

